Faculté de Médecine d'Oran
Année Universitaire 2025/2026

MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE

Dr Boubekki H.
Service de Réanimation Médicale (EHU)

PHYSIOLOGIE DE L'HEMOSTASE

Le sang circule sous pression à l'état liquide dans le système vasculaire. En cas de blessure d'un vaisseau, pour arrêter l'hémorragie, les plaquettes obturent la brèche en venant y agréger. C'est la première phase = **HEMOSTASE PRIMAIRE**. Mais cet agrégat plaquettaire est instable et perméable; il doit être consolidé. C'est le rôle de la **COAGULATION** qui transforme, après une cascade d'activations enzymatiques, le fibrinogène soluble en fibrine insoluble qui vient consolider l'agrégat plaquettaire en le coiffant d'un fin réseau fibrineux. La masse fibrino-plaquettaire qui a obturé la brèche sera résorbée les jours suivants par la troisième phase, la **FIBRINOLYSE**, après réparation de la paroi du vaisseau.

PHYSIOLOGIE DE L'HEMOSTASE PRIMAIRE (HP)

Etudier la physiologie de l'HP, c'est envisager les différents mécanismes mis en œuvre pour l'arrêt d'une hémorragie provoquée par la section de vaisseaux de petit calibre (capillaires, veinules, artérioles).

I- LES FACTEURS DE L'HP :

L'HP fait intervenir l'endothélium et le sous-endothélium du vaisseau, les plaquettes et des facteurs plasmatiques: le facteur Willebrand et le fibrinogène.

1. LA PAROI VASCULAIRE (ENDOTHELIUM + SOUS-ENDOTHELIUM)

1a- L'ENDOTHELIUM est constitué d'une couche monocellulaire qui tapisse l'intérieur de tous les vaisseaux. Ces cellules synthétisent plusieurs composés vers le courant circulatoire: − Facteur Willebrand

− Prostacycline (ou PGI2) et du monoxyde d'azote (NO), puissants agents antiagrégants − Activateur tissulaire du plasminogène (rôle dans la fibrinolyse).

L'endothélium normal est une surface thrombo-résistante, c'est-à-dire qui prévient toute activation plaquettaire.

1b- le SOUS-ENDOTHELIUM est constitué par du collagène, des micro-fibrilles, de la Fibronectine, de l'élastine, une membrane basale. Le sous-endothélium est une surface thrombogène, c'est-à-dire qui entraîne l'activation plaquettaire.

2. LES PLAQUETTES (PQ)

Les plaquettes sont produites dans la moelle osseuse par les mégacaryocytes. Dans le sang, les plaquettes sont au nombre de 150 000 à 400000/mm^3. Leur durée de vie est de 8 à 10

jours. La PQ est une cellule anucléée, ayant une forme de disque à l'état de repos. Cette cellule est délimitée par une membrane plasmique composée de glycoprotéines et de phospholipides. Dans le cytoplasme, on retrouve des granules denses et des granules alpha. Ces granules contiennent des composés importants qui interviennent dans la phase d'agrégation plaquettaire.

3. LE FACTEUR WILLEBRAND (FW)

C'est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par la cellule endothéliale et nécessaire à l'adhésion des PQ aux fibrilles sous-endothéliales. Le FW qui s'est lié au sous-endothélium fixe les PQ au niveau d'un site spécifique membranaire : la glycoprotéine Ib. Dans le sang circulant, il est étroitement associé au facteur VIII coagulant auquel il sert de protéine porteuse. De ce fait, le déficit en FW (maladie de WILLEBRAND) s'accompagne d'un déficit en facteur VIII d'intensité variable. On note une augmentation du FW chaque fois qu'il y a stress, exercice physique intense, au cours de la grossesse (synthèse par le placenta), dans les états de détérioration vasculaire, après perfusion intraveineuse lente de MINIRIN® (ce médicament est utilisé pour préparer les patients ayant un déficit modéré en FW à une intervention chirurgicale ou à une ponction d'organe profond).

4. LE FIBRINOGENE

Le fibrinogène est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par le foie. Il joue un rôle très important dans la coagulation mais c'est aussi le cofacteur de l'agrégation plaquettaire.

II - MISE EN JEU DES DIFFERENTS PARAMETRES DE L'HP

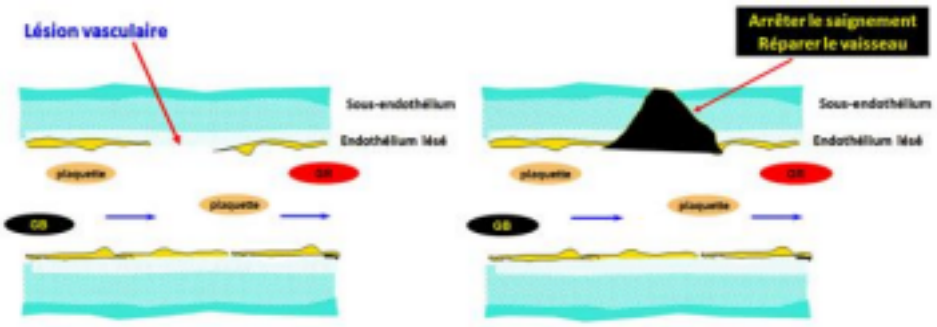
Cette mise en jeu est rapide, elle aboutit à la formation d'un thrombus blanc de nature plaquettaire qui va colmater la brèche vasculaire. Les diverses phases sont les suivantes :

1. RUPTURE DE LA CONTINUITE VASCULAIRE, EFFRACTION VASCULAIRE Les pertes sanguines pendant les 30 premières secondes sont assez réduites pour augmenter quelque peu par la suite.

Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que, immédiatement après l'incision, survient une brève **Vasoconstriction** qui est la conséquence d'une stimulation réflexe des muscles lisses des artérioles situées en amont. Elle favorise l'accumulation locale de substances hémostatiques.

La sérotonine et le thromboxane A2 (TXA2) libérés par les plaquettes activées, sont de puissants agents vasoconstricteurs. En même temps, il y a mise en contact de facteur tissulaire (facteur III tissulaire) qui provient de l'extérieur du vaisseau, avec les facteurs plasmatiques de la coagulation.

C'est le point de départ de la coagulation qui aboutit à la formation précoce de thrombine.



2. <u>ADHESIVITE PLAQUETTAIRE</u>

Les PQ ne se fixent pas sur l'endothélium sain. Par incision du vaisseau, il y a rupture de la couche endothéliale exposant alors les structures sous-endothéliales auxquelles les PQ vont dès lors adhérer par deux réactions :

- Adhésion directe des PQ aux fibres de collagène sous-endothéliales (minoritaire) – Adhésion des PQ à des structures sous-endothéliales induites par le facteur WILLEBRAND qui, lié au sous-endothélium, fixe les PQ au niveau de la glycoprotéine membranaire Ib (majoritaire).



3. <u>ACTIVATION PLAQUETTAIRE</u>

Elle survient après l'adhésion. Il se produit :

3a- Des changements morphologiques : les PQ fixées aux structures sous-endothéliales perdent rapidement leur <u>structure discoïde</u>. Elles s'étalent sur la paroi vasculaire. Cette déformabilité de la membrane plaquettaire rend possible l'agrégation plaquettaire car lorsque deux PQ activées entrent en contact, elles vont s'efforcer d'étendre au maximum cette surface de contact.

3b- Une synthèse de thromboxane A2 : à partir des phospholipides plaquettaires, il y a synthèse de <u>thromboxane A2</u> (TXA2) qui entraîne quasi instantanément la libération du contenu des granules. Cette action n'est pas limitée à la PQ où il a été synthétisé mais s'étend également aux PQ circulantes.
Le TXA2 est un puissant inducteur de l'agrégation plaquettaire. L'**ASPIRINE** exerce un effet antiagrégant plaquettaire en bloquant la synthèse des précurseurs du TXA2.

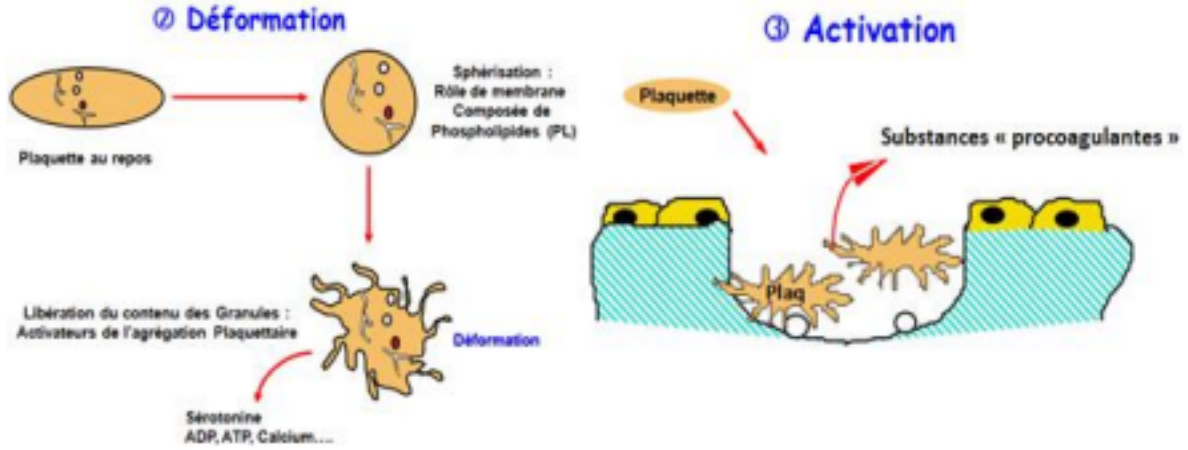
3c- Une réaction de libération, induite par le TXA2, durant laquelle est sécrétée le contenu des granules plaquettaires:

- SEROTONINE et TXA2, substances vasoactives qui diminuent le diamètre des

vaisseaux

- ADP et TXA2 qui entraînent le recrutement in situ de plaquettes circulantes qui vont alors s'accoler aux premières : c'est la phase suivante d'agrégation.

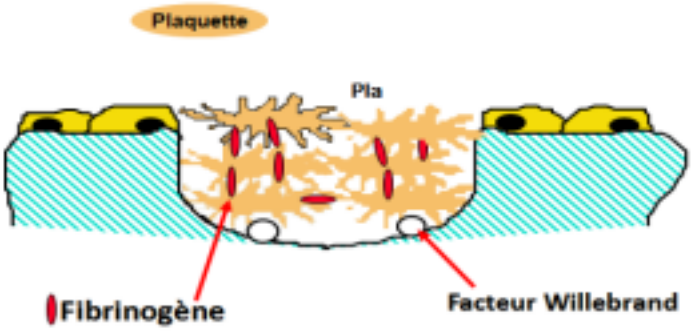
3d- l'apparition d'une activité procoagulante : la membrane d'une PQ en train de se contracter, acquiert de nouvelles propriétés physico-chimiques favorisant la coagulation. Il y a exposition de phospholipides membranaires spécifiques auxquels les facteurs de coagulation peuvent se fixer. On appelle facteur 3 plaquettaire (F3P) cette fonction de catalyser de la coagulation propre aux PQ en contraction.



4. <u>AGREGATION</u>

L'agrégat plaquettaire va croître par apposition successive de nouvelles plaquettes. Au niveau de la membrane plaquettaire, le complexe glycoprotéinique IIb/IIIa est indispensable. Grâce à ce site, le fibrinogène va se fixer sur la membrane pour former avec le Ca++ des ponts inter-plaquettaires qui permettent la formation de l'agrégat.

Il se forme finalement un gros amas plaquettaire, l'agrégat plaquettaire hémostatique, qui arrête en partie l'hémorragie mais qui doit être consolidé par le réseau de fibrine créé par la coagulation.



PHYSIOLOGIE DE LA COAGULATION

La coagulation correspond à la conversion du fibrinogène soluble en fibrine insoluble qui constitue l'armature du caillot. Cette conversion est la conséquence d'une cascade de réactions enzymatiques à laquelle participent plusieurs protéines plasmatiques appelées facteurs de la coagulation.

I - LES FACTEURS DE LA COAGULATION – NOMENCLATURE

Les facteurs de la coagulation ont été découverts et décrits comme une activité biologique présente chez l'homme normal et absente au cours de maladies hémorragiques héréditaires. On leur a attribué un numéro en chiffre romain. On regroupe certains facteurs dans diverses classes, ce qui permet d'évoquer rapidement certains diagnostics :

1) FACTEURS SYNTHETISES PAR LE FOIE

La plupart des facteurs de la coagulation sont synthétisés par l'hépatocyte. En conséquence, chaque fois qu'il existera une insuffisance hépatocellulaire sévère, quelle qu'en soit la cause (cancer du foie, cirrhose, hépatite virale, hépatite toxique médicamenteuse) on observera une diminution globale, non sélective de l'activité de tous les facteurs de la coagulation.

2) FACTEURS SYNTHETISES EN PRESENCE DE VITAMINE K

La vitamine K intervient au stade terminal de la synthèse de quatre facteurs de la coagulation:

- Prothrombine (II)
- Proconvertine (VII)
- Facteur anti hémophilique B (IX)
- Facteur Stuart (X)

La vitamine K contrôle également la synthèse des protéines C et S qui interviennent dans l'inhibition de la coagulation en inactivant les facteurs V et VIII.

En cas de déficit en vitamine K (défaut d'apport alimentaire, ictère par rétention, absorption accidentelle de raticide, prise de médicaments anti-vitamine K, antibiothérapie prolongée qui stérilise la flore microbienne saprophyte intestinale qui synthétise habituellement de la vitamine K dans l'intestin, diarrhée profuse) le foie libère des facteurs de coagulation anormaux, qui ne se lient pas aux phospholipides et que l'on appelle les PIVKA (protein induced by vitamine K absence).

Ceci explique l'effet anticoagulant des médicaments anti-vitamine K.

3) FACTEURS CONSOMMES AU COURS DE LA COAGULATION

Un certain nombre de facteurs de la coagulation sont présents dans le plasma, mais absents du sérum après coagulation. Ce sont les facteurs consommés, qui sont au nombre de cinq: ○ le fibrinogène (I)

- la prothrombine (II)
- l'accélérine (V)
- le facteur anti hémophilique A (VIII)
- le facteur stabilisant la fibrine (XIII)

Dans certaines circonstances pathologiques (hémolyse importante, traumatisme majeur, incident obstétrical, morsure de serpent, etc.…), il peut survenir une activation anormale de la coagulation dans la circulation.

C'est une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). Le diagnostic sera évoqué devant la chute des seuls facteurs dits consommés et des plaquettes.

N° Facteur	Nom	Particularité	Demi-vie	Taux mini Nécessaire
Facteur I	Fibrinogène	Absent du sérum	4-6 jours	0,5 à 1 g/l
Facteur II	Prothrombine	→ Vit K dépendant <5 % dans sérum	3-4 jours	40 %
Facteur V	Proaccélérine	Absent du sérum	12-36 h	10-15 %
Facteur VII	Proconvertine	→ Vit K dépendant	4-6 h	5-10 %
Facteur VIII	Anti-hémoph A	Absent du sérum	10-16 h	30-40%
Facteur IX	Anti-hémoph B	→ Vit K dépendant	24 h	30-40%
Facteur X	Stuart	→ Vit K dépendant	1-2 jours	10-20%
Facteur XI	Rosenthal		1-2 jours	30%
Facteur XII	Hageman		2-3 jours	0% ?
Facteur XIII	Stabilisant fibrine		3-7 jours	2%

4) FACTEURS CONTACT

Il s'agit du facteur XII, de la Prékallikréine et du kininogène de haut poids moléculaire. Le facteur XII participe à l'activation du plasminogène, le précurseur de la plasmine qui est l'enzyme de la fibrinolyse (voir fibrinolyse).

Un déficit même important en facteur XII, en Prékallikréine ou en kininogène n'entraîne jamais d'hémorragie malgré des tests de coagulation in vitro très perturbés (allongement du temps de céphaline-activateur ou TCA).

5) PHOSPHOLIPIDES ET CALCIUM

Les phospholipides constituent une surface catalytique pour l'activation enzymatique des facteurs de la coagulation. Ces phospholipides proviennent de deux sources principales, plaquettaire et tissulaire. Au cours de l'activation plaquettaire, la membrane subit des modifications qui lui confèrent un pouvoir catalytique (FP3).

La cellule endothéliale libère au cours des blessures et des lésions tissulaires, du facteur III tissulaire ou thromboplastine qui offre une surface catalytique pour les réactions de coagulation.

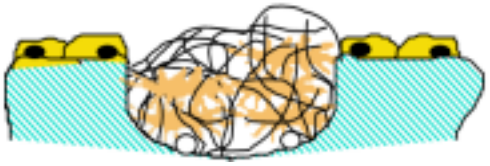
Le calcium est nécessaire à toutes les étapes d'activation enzymatique de la coagulation, excepté celle du facteur contact (facteur XII). Il suffit donc de complexer le calcium du sang, par exemple par du citrate de sodium, pour le rendre incoagulable. Cette propriété est utilisée pour anticoaguler le sang destiné aux examens d'hémostase.

6) FIBRINOGENE ET FACTEUR STABILISANT LA FIBRINE

Le fibrinogène est synthétisé par l'hépatocyte. Son taux normal est compris entre 1,5 et 3,5 grammes/litre. Il augmente dans les états infectieux et inflammatoires. Il diminue dans les défauts de synthèse acquis (insuffisance hépatique) ou congénitaux (hypo fibrinogénémie congénitale).

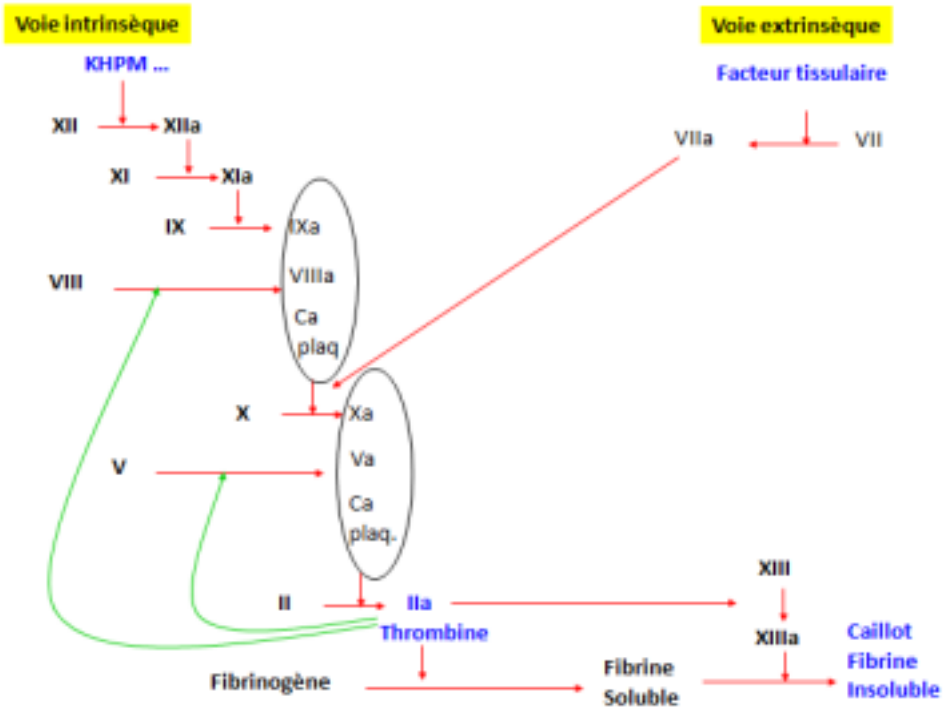
Il est absent dans les afibrinogénémies congénitales. Le facteur stabilisant la fibrine (XIII) est activé par la thrombine en présence de calcium et crée des liaisons covalentes entre les monomères de fibrine.

« Caillot de fibrine »



II- MISE EN JEU DES FACTEURS DE LA COAGULATION

La coagulation est une cascade d'activations enzymatiques: un pro-enzyme est activé par protéolyse et ce facteur activé active à son tour un autre pro-enzyme intervenant à un stade ultérieur selon le schéma simplifié ci-dessous.
Le stade ultime est la transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble, responsable du changement d'état physique du sang qui passe ainsi de l'état liquide à l'état solide.



III- LE SYSTEME DE REGULATION DE LA COAGULATION

1. NECESSITE D'UN SYSTEME DE REGULATION

Les facteurs de la coagulation sont présents en excès dans le sang. Etant donné le caractère auto catalytique des réactions de coagulation, l'activation des facteurs se propagerait de proche en proche s'il n'existait des mécanismes régulateurs puissants.

2. MECANISMES NON SPECIFIQUES

La coagulation reste focalisée à la surface du thrombus blanc plaquettaire qui adhère à la paroi du vaisseau. L'excès en facteurs de coagulation activés est dispersé par le flux sanguin. Par ailleurs, la fibrine adsorbe la thrombine et l'inactive.

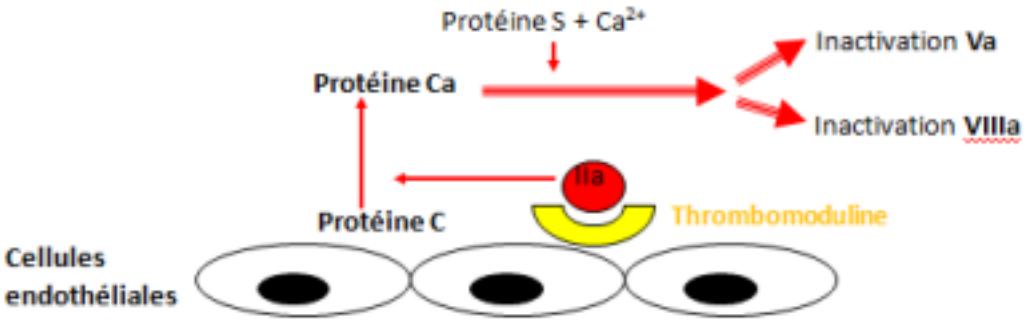
3. L'ANTITHROMBINE ET L'ALPHA-2-MACROGLOBULINE

L'antithrombine est l'inhibiteur fondamental de la coagulation. Son action s'exerce au niveau de la thrombine et de tous les enzymes activés de la coagulation. Un déficit même modéré

en antithrombine constitue un facteur de risque de thrombose important. La vitesse d'inhibition par l'antithrombine des enzymes activés est considérablement accélérée par l'héparine: l'antithrombine est le cofacteur de l'héparine. L'alpha 2macroglobuline quant à elle, supporte environ 30% du pouvoir anti-thrombinique du plasma.

4. <u>LE SYSTEME PROTEINE C - PROTEINE S - THROMBOMODULINE</u>

La protéine C est un inhibiteur de la coagulation vitamine K dépendant. L'activation de la protéine C est assurée par la thrombine liée à la thrombomoduline enchâssée dans l'endothélium. La protéine C activée détruit les facteurs Va et VIIIa en présence de son cofacteur, la protéine S également vitamine K dépendante. Il existe des déficits congénitaux en protéine C ou en protéine S, qui s'accompagnent en général d'accidents thromboemboliques récidivants.



LA FIBRINOLYSE

Cette dernière phase intervient après la coagulation pour éliminer le clou hémostatique formé de fibrine et d'une façon générale tous les dépôts fibrineux qui peuvent se former dans l'organisme quelle que soit leur localisation.

I- LES FACTEURS DE LA FIBRINOLYSE : PLASMINOGENE ET PLASMINE

Le plasminogène est le précurseur inactif de la plasmine. Il est synthétisé par l'hépatocyte. La conversion du plasminogène en plasmine peut se faire grâce à de nombreux activateurs:

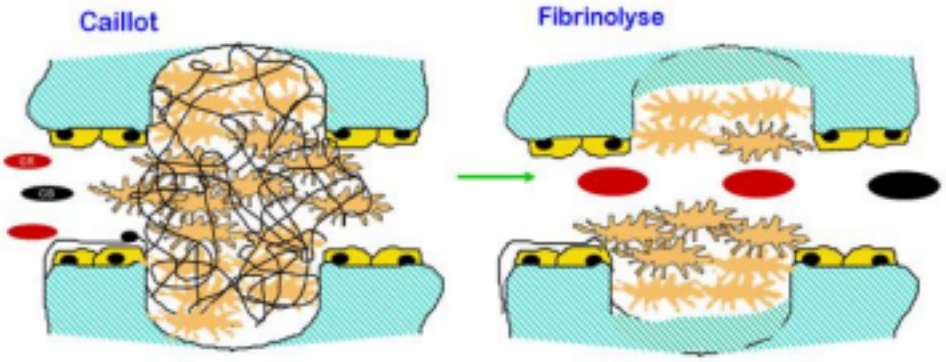
1- L'activateur tissulaire du plasminogène ou tPA : C'est le principal activateur. Il est synthétisé et stocké par les cellules endothéliales des vaisseaux et libéré sous l'influence du stress, de l'exercice physique, de l'anoxie, de la stase, de l'acidose, de l'adrénaline. Il peut être synthétisé par génie génétique (tPA recombinant ou rtPA) et utilisé comme médicament thrombolytique

2- La pro-urokinase : Sa concentration plasmatique est faible. Elle est transformée en urokinase active sous l'action de la plasmine.

3- L'urokinase : Elle est synthétisée par le rein et éliminée dans les urines. On l'utilise en thérapeutique thrombolytique après obtention à partir d'urine humaine ou par culture de cellules rénales embryonnaires.

4- Le facteur XIIa et la Kallikréine : Leur action est modeste par rapport aux autres activateurs

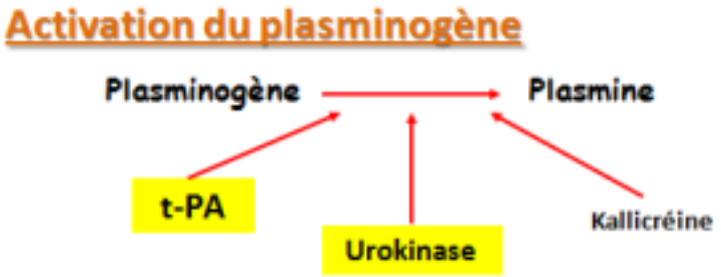
5- La Streptokinase : Est un activateur médicamenteux, obtenu à partir de cultures de streptocoques ß hémolytiques. C'est une substance antigénique qui provoque l'apparition d'anticorps.



II- LES INHIBITEURS DE LA FIBRINOLYSE

Il existe également des inhibiteurs. Le principal est représenté par l'alpha-2-anti-plasmine qui est capable de neutraliser très rapidement la plasmine libre non fixée sur le caillot de fibrine. Le second inhibiteur, l'alpha-2macroglobuline, est d'action plus modeste. Le PAI est un inhibiteur de l'activateur tissulaire du plasminogène.

Il existe également des inhibiteurs médicamenteux, utilisés en cas d'hémorragie importante au cours des thrombolyses thérapeutiques: Aprotinine, Acide tranexamique, Acide epsilon amino-caproïque.

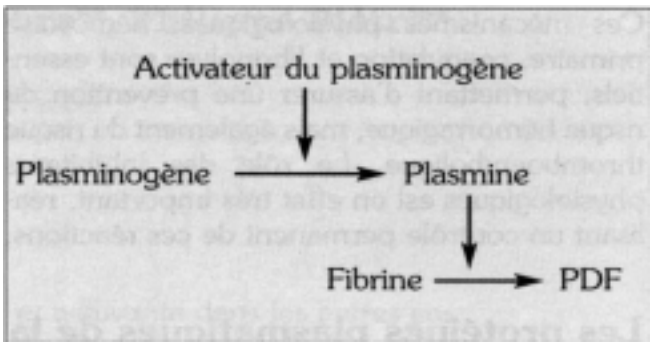


III- MISE EN JEU DES FACTEURS DE LA FIBRINOLYSE

La plasmine solubilise le caillot en réalisant de multiples scissions protéolytiques. Au cours de cette protéolyse apparaissent des produits de dégradation de la fibrine = PDF (**D dimères**).

La libération éventuelle de plasmine dans le plasma est suivie de sa neutralisation immédiate par son principal inhibiteur naturel, l'alpha2anti-plasmine.

En cas de débordement de cet inhibiteur dans les fibrinolyses thérapeutiques ou les hyper fibrinolyses pathologiques, la plasmine libre peut dégrader le fibrinogène avec apparition de PDF (produits de dégradation du fibrinogène), le facteur V et le VIII.



Maladie Thrombo-embolique

1. INTRODUCTION :

La maladie veineuse thrombo-embolique (MVTE) est une pathologie fréquente, elle regroupe la thrombose veineuse profonde (TVP) et son risque vital immédiat **l'embolie pulmonaire** (EP).

IL s'agit d'une pathologie plurifactorielle (thrombophilie biologique, stase veineuse, circonstances favorisantes multiples) qui accompagne le plus souvent une autre pathologie.

La MVTE est une pathologie fréquente et grave.

Elle constitue une importante cause de morbidité et de mortalité avec une incidence moyenne annuelle > 1 par 1000 personnes/année.

2. DÉFINITION :

La TVP se définit comme une obstruction veineuse partielle ou totale par un thrombus endoluminal résultant d'une coagulation de sang dans une lumière veineuse. L'EP est la conséquence de l'obstruction des artères pulmonaires ou de leurs branches par des thrombi. Elle est le plus souvent secondaire a une TVP.

3. PHYSIOPATHOLOGIE

L'histoire naturelle de la TVP est indissociable de celle de l'embolie pulmonaire (EP) qui en fixe le pronostic vital immédiat justifiant le concept de maladie thrombo- embolique veineuse (MTEV).

ANOMALIES DE L'HÉMOSTASE

2. THROMBOSES

Formation inopportune d'un caillot dans un Vx sanguin intact

1. Activation excessive de la coagulation :

- Déficit des inhibiteurs de la coagulation (AT, PC, PS)
- Excès de facteur de la coagulation ex: VIII

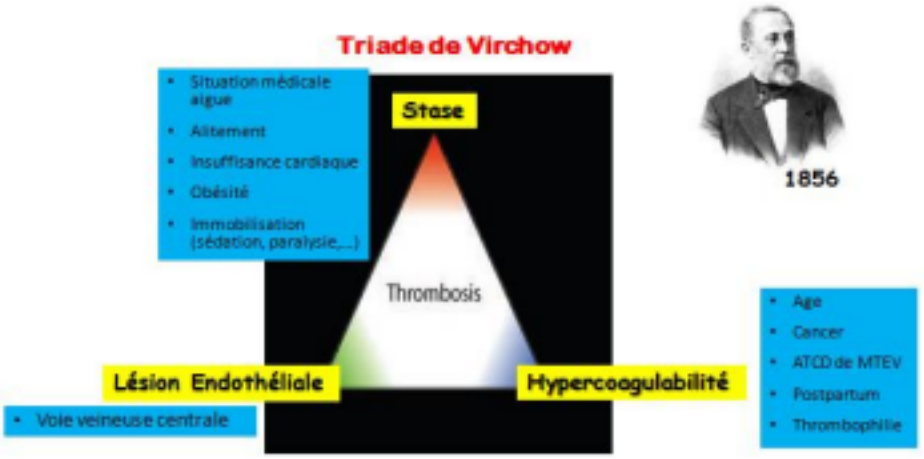


2. Hypofibrinolyse

C'est au pathologiste berlinois **Rudolph Virchow** au milieu du XIXe siècle que revient le mérite d'avoir décrit les principaux mécanismes impliques dans la survenue des thromboses dans une triade qui porte son nom (figure 1) :

- Ralentissement de l'écoulement sanguin (stase sanguine)
- Altération de la paroi vasculaire ou facteur pariétal (lésion pariétale)
- Modification de l'hémostase (hypercoagulabilité ou thrombophilie)

Au cours de certaines pathologies, la thrombose peut être secondaire à plusieurs de ces mécanismes en même temps.
Le point de départ du thrombus est le plus souvent distal, dans des zones de ralentissement du flux (veines soléaires, valvules, abouchement de collatérales).
Il peut s'étendre en amont, être occlusif ou se fragmenter pour migrer vers le champ pulmonaire. Une lyse spontanée peut survenir lorsque le thrombus est peu volumineux et si le facteur étiologique disparait rapidement.



Constitution du thrombus

- Le point de départ est un nid valvulaire
- Un thrombus fibrino-plaquettaire
- La tête du thrombus flotte dans le courant sanguin et peut se détacher réalisant l'embolie pulmonaire.



La thrombose se développe au niveau d'une bifurcation ou d'une valve

Viscosité = Propriété d'un fluide qui tend à empêcher son écoulement lorsqu'il est soumis à une force.

Les fluides de grande viscosité résistent à l'écoulement et les fluides de faible viscosité s'écoulent facilement.

Les facteurs influençant la Viscosité

Facteurs macro-rhéologiques

- Hématocrite
- Protéines plasmatiques

Facteurs micro-rhéologiques

- Hyper agrégation des GR
- Déformabilité cellulaire
- Interactions cellules-paroi Vx

Formation, durant la vie, dans les cavités cardio-vasculaires, d'un caillot sanguin.

Les thrombus sont :

– Adhérents à la paroi vasculaire
– Friables
– À surface rugueuse

On distingue :

– Le thrombus oblitérant
– Le thrombus mural ou pariétal

On distingue 3 variétés de thrombus (en microscopie):

– Thrombus rouge
– Thrombus blanc
– Thrombus mixte:
  - *La tête : thrombus blanc*
  - *Le corps : constitué* d'agrégat fibrino-plaquettaire et d'agrégat fibrinocruorique
  - *La queue : thrombus rouge, pouvant se détacher et* devenir un embole

On distingue :

Thromboses artérielles:

– Souvent due à l'athérosclérose, permet l'activation plaquettaire et activation de la

coagulation.

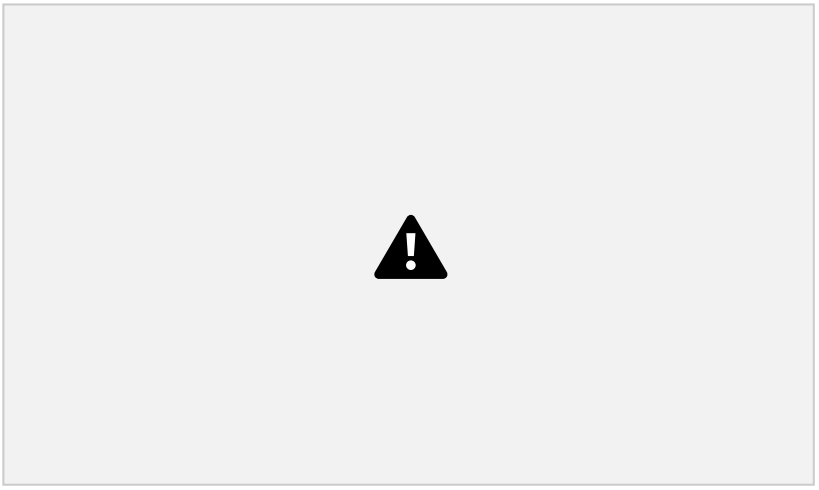
– Génératrices d'ischémie et de nécroses tissulaires: IDM, AVC,…

Thromboses veineuses : MTEV

– Siège électif = membres inférieurs

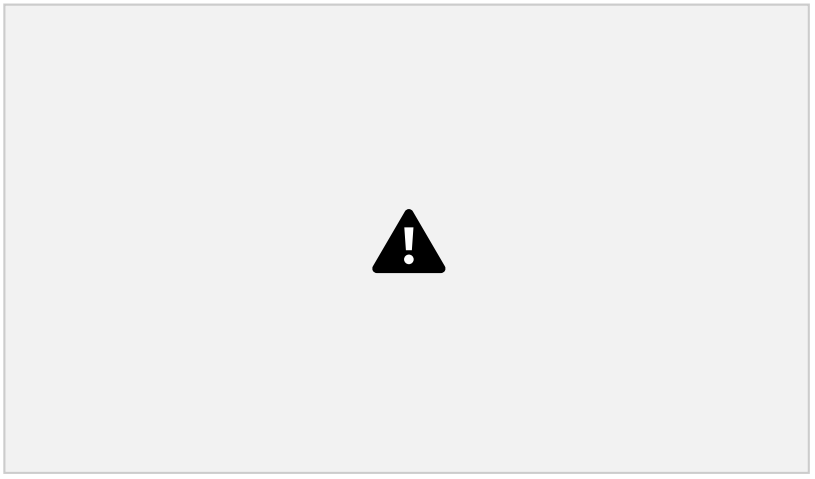
– Thromboses veineuses profondes compliquées ou non d'embolie pulmonaire – MTEV fréquente chez le sujet âgé, mais peut commencer chez le jeune surtout si déficit en inhibiteur de la coagulation.





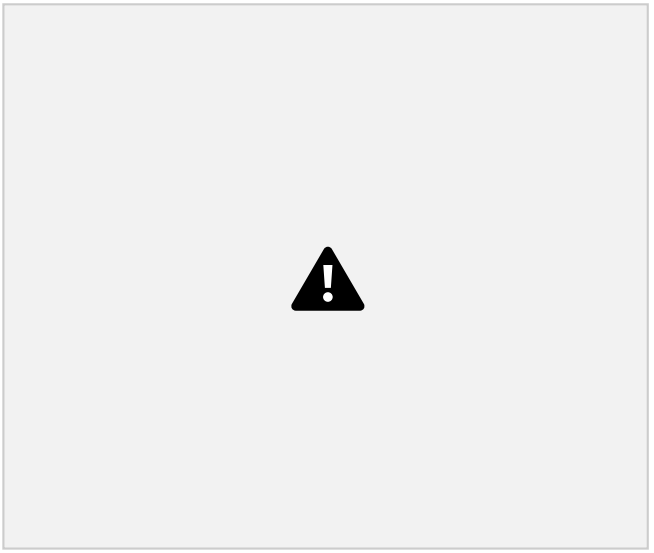
Facteurs prédisposants :

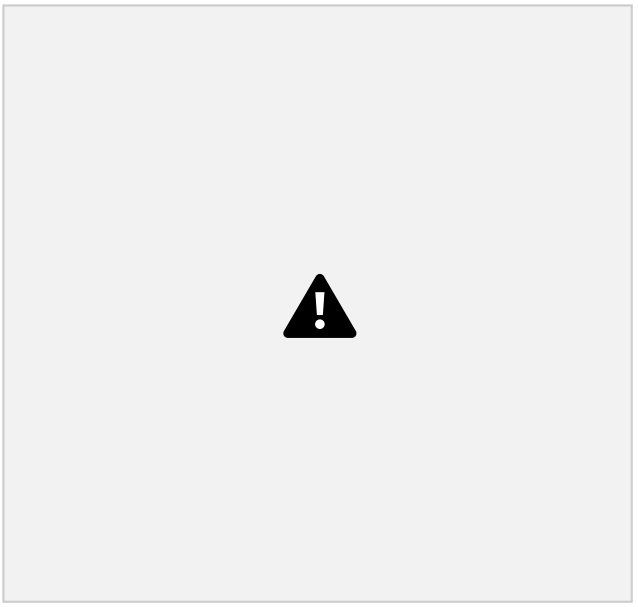
Elle est souvent favorisée par un contexte particulier, postopératoire, obstétrical ou médical.

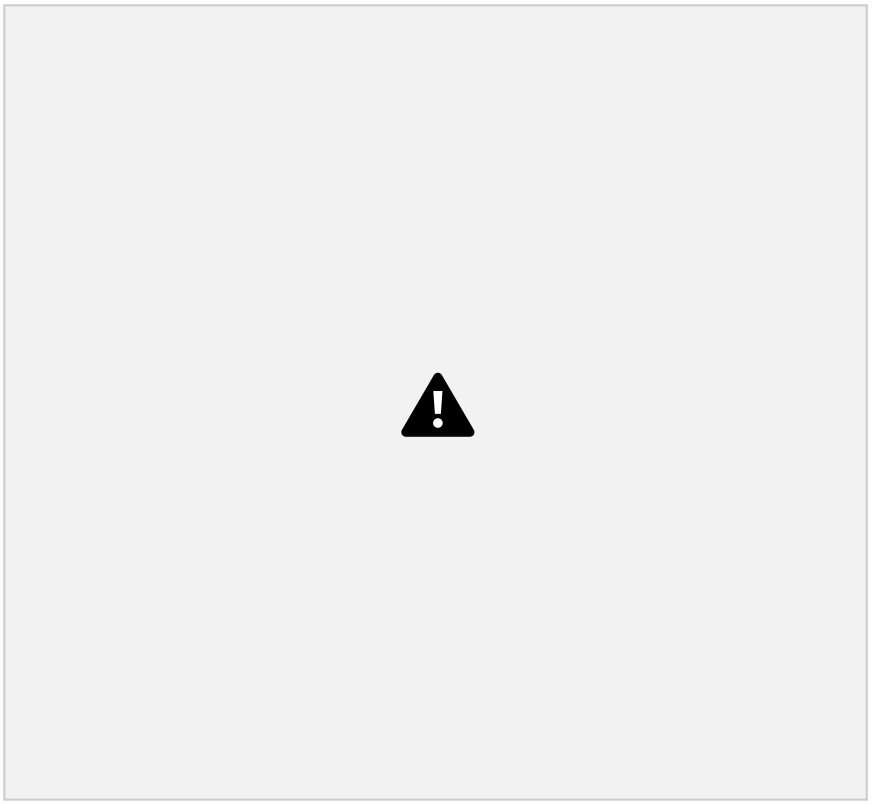


La TVP peut survenir sans facteur déclenchant ou chez des patients présentant des facteurs

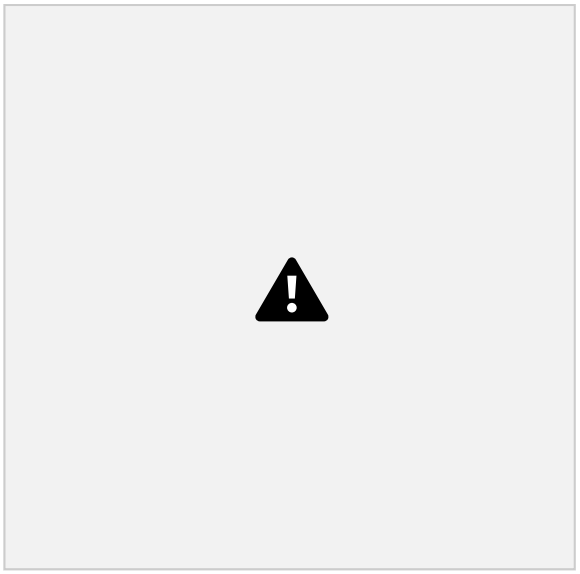
de risque propres : on parle de **Thrombophilie**







Risque de maladie veineuse thromboembolique associé
Aux thrombophilies constitutionnelles



Extension – migration

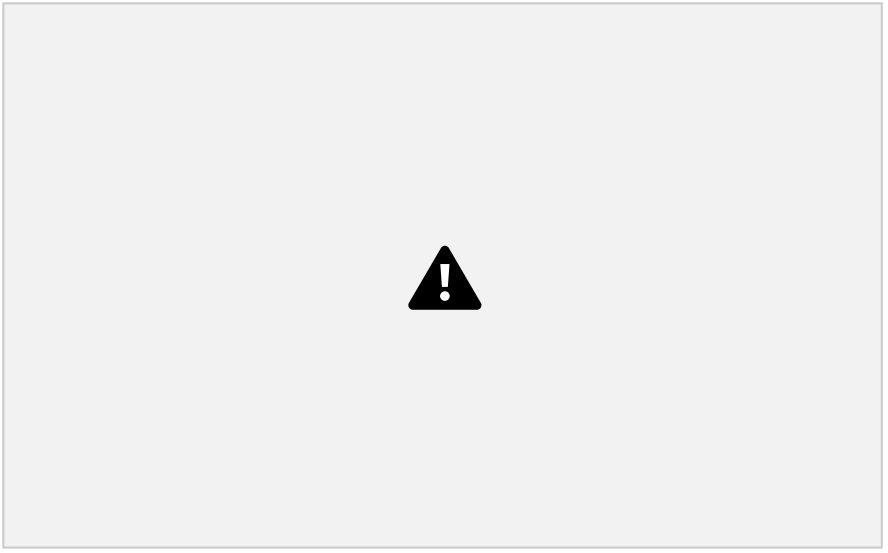
− Le risque d'extension ou de migration est plus important si le facteur favorisant persiste (alitement, par exemple) ou si le thrombus est d'emblée volumineux. − Le traitement anticoagulant prophylactique favorise la lyse spontanée du thrombus et prévient son extension.

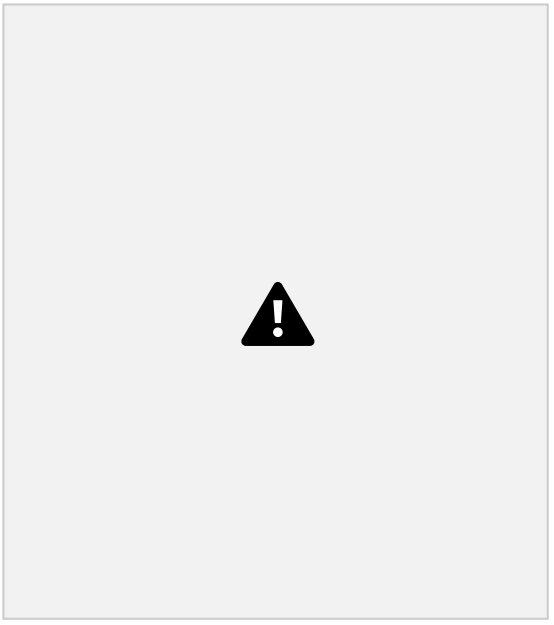
− Les TVP distales, souvent asymptomatiques, sont rarement responsables d'une EP ayant des conséquences cliniques importantes.

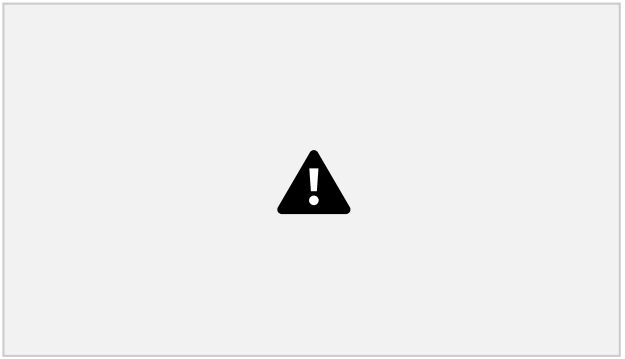
− Près de 25% des TVP distales asymptomatiques font l'objet d'une extension proximale le plus souvent durant la semaine suivant le début des symptômes. − Une TVP proximale

a une forte probabilité de s’associer à une EP qui peut être asymptomatique.

- Près de 70% des personnes manifestant une EP, ont en réalité une TVP asymptomatique.
- Plus de 50% des malades présentant des symptômes de TVP ont une EP silencieuse.



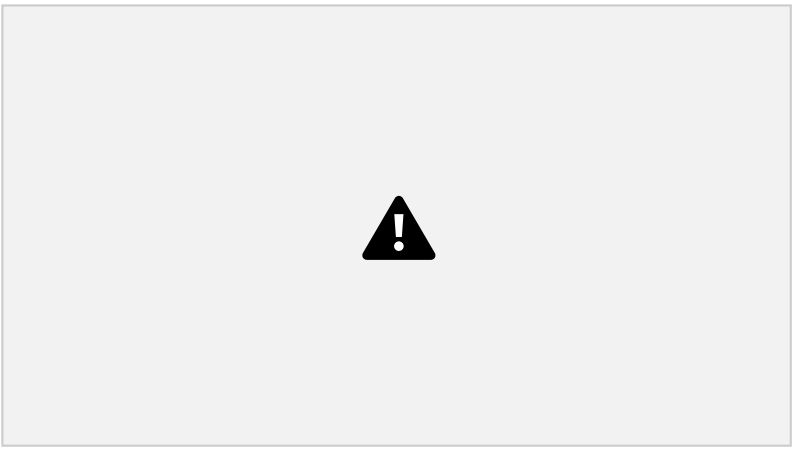


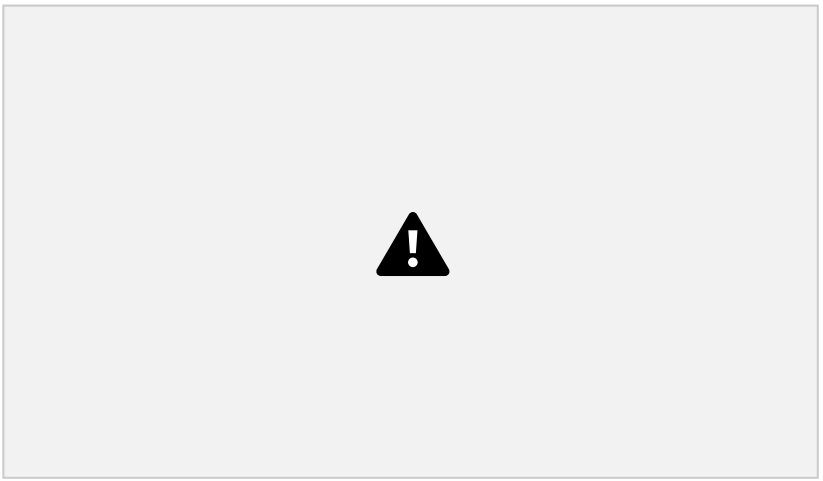




Complication aigue = Embolie Pulmonaire

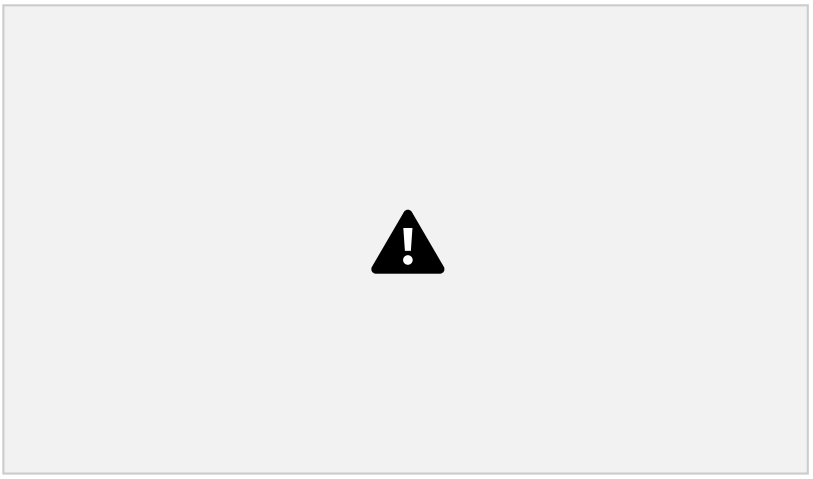
- Dans plus de 90 % des cas, elle naît dans les veines profondes des membres inférieurs (TVP)
- Ce risque est d'autant plus grand que la localisation du thrombus est proximale



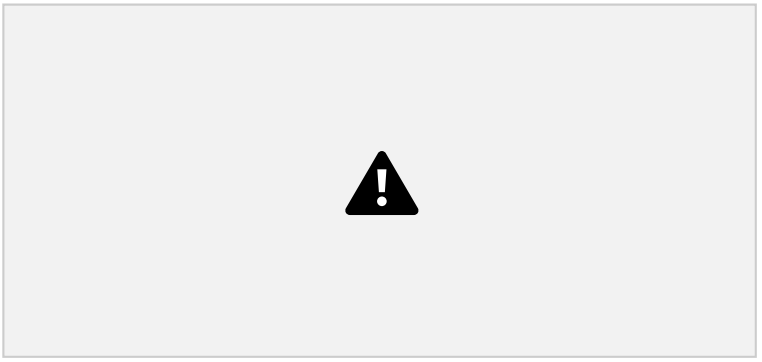


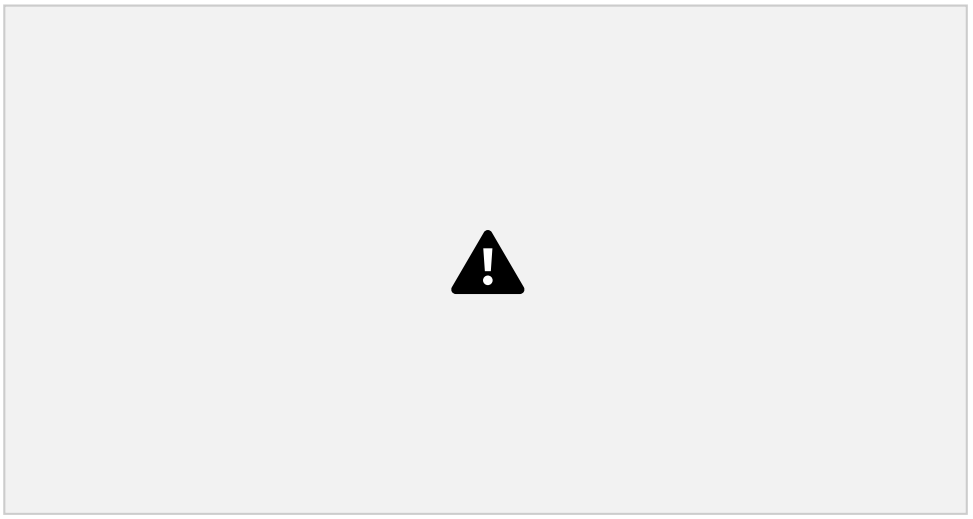
Récidive / syndrome post-thrombotique

- En l'absence de traitement anticoagulant, une TVP proximale symptomatique récidive une fois sur deux dans les 3 mois.
- Le risque de récidive est plus élevé en cas de persiste des facteurs déclenchants. − La récidive d'une TVP distale est deux fois moins fréquente que celle d'une TVP proximale.



- Le syndrome post-thrombotique (SPT) apparait dans les suites d'une TVP symptomatique, le plus souvent dans les 2 ans suivant la TVP. Il peut régresser mais l'incidence du SPT invalidant est de près de 10% à 5 ans.
- Le risque est nettement diminué par une contention veineuse, instaurée dès la phase initiale de la TVP et maintenue pendant au moins 3 mois.





Conclusion

La maladie Thrombo-embolique reste fréquente et grave.